Clínica Cirúrgica · Estações OSCE — Cirurgia Digestiva

13 estações de 5 minutos · cada estação contém: impresso do candidato, impressos para entrega, instruções ao ator/avaliador, gabarito e checklist (cada parte começa em nova página)

1. **#CD-1** — Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório (Abdome agudo perfurativo — úlcera péptica perfurada)
2. **#CD-2** — Azia há anos que volta toda vez que para o remédio (Doença do refluxo gastroesofágico — indicação de fundoplicatura)
3. **#CD-3** — Dificuldade para engolir que piora a cada semana (Câncer de esôfago (carcinoma espinocelular))
4. **#CD-4** — Caroço na virilha que aparece ao fazer força (Hérnia inguinal)
5. **#CD-5** — Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada (Colecistite aguda litiásica)
6. **#CD-6** — Dor forte em faixa na parte de cima da barriga (Pancreatite aguda biliar)
7. **#CD-7** — Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus (Doença hemorroidária)
8. **#CD-8** — Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias (Câncer de vesícula biliar (achado incidental) e de vias biliares)
9. **#CD-9** — Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias (Diverticulite aguda complicada (Hinchey Ib))
0. **#CD-10** — Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito (Apendicite aguda)
1. **#CD-11** — Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago (Cirurgia bariátrica — indicação e preparo)
2. **#CD-12** — Anemia e cansaço em homem de 61 anos (Câncer de cólon direito)
3. **#CD-13** — Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu (Adenocarcinoma de cabeça de pâncreas)

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-1 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório

CENÁRIO

Pronto-socorro, 14h.

PACIENTE

Rogério, 48 anos, sexo masculino, mecânico.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor abdominal súbita e muito intensa em “boca do estômago” há 3 horas, que se espalhou para toda a barriga.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Colete dados dirigidos de anamnese e exame físico (achados fornecidos mediante solicitação).
2. Solicite o exame de imagem inicial, interprete-o e formule o diagnóstico.
3. Descreva a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-1 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
112/70 mmHg	112 bpm	24 irpm	37,8 °C	96%	78 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, imóvel no leito (evita se mexer), fácies de dor, desidratado 1+/4+.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

ABDOME: plano, contratura muscular involuntária difusa (abdome “em tábua”); dor intensa à palpação difusa, máxima em epigástrio; descompressão brusca dolorosa difusa (Blumberg positivo); PERCUSSÃO: perda da macicez hepática (sinal de Jobert); ruídos hidroaéreos abolidos

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Leucócitos	**16.400/mm³ (6% bastões)**	4.000–11.000/mm³
Amilase	**140 U/L**	< 100 U/L
Creatinina	1,2 mg/dL	0,7–1,3 mg/dL
Lactato	**2,4 mmol/L**	< 2 mmol/L

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

RADIOGRAFIA DE TÓRAX PA EM ORTOSTATISMO (entregar se solicitada a rotina de abdome agudo ou RX de tórax ortostático): pneumoperitônio — imagem de ar livre subdiafragmático bilateral, em “crescente”, mais evidente à direita.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-1 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico e radiografia SOMENTE se solicitados. Se o candidato pedir endoscopia digestiva alta, informar que “está contraindicada nesta situação” e ANOTAR. Se pedir TC, informar que “está disponível em 1 hora — algum exame mais rápido?”.

PERFIL DO PACIENTE

Rogério, 48 anos, mecânico, tabagista 1 maço/dia, etilista social. Há 2 semanas usa diclofenaco 50 mg 3x/dia por dor lombar, por conta própria. Tem “gastrite” há anos, com queimação que melhora ao comer.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, deu uma dor de repente aqui em cima da barriga, como uma facada. Agora dói a barriga inteira, não consigo nem me mexer.”
Medicamentos	“Tô tomando diclofenaco por causa da coluna, umas três vezes por dia, faz duas semanas.”
Sintomas prévios	“Eu tenho uma queimação no estômago faz anos, que melhora quando eu como.”
Vômitos / evacuação	“Vomitei uma vez. Evacuei ontem normal.”
Pergunta ativa	“O que eu tenho? Vou ter que operar?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Uso de diclofenaco por conta própria há 2 semanas — só revela se perguntado sobre medicações
- Tabagismo — só revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Imóvel, com dor intensa, evita respirar fundo e se mexer; joelhos fletidos.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-1 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório

Abdome agudo perfurativo — úlcera péptica perfurada (provavelmente duodenal/pré-pilórica), com peritonite difusa, associada a uso de AINE, tabagismo e provável infecção por H. pylori.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Pancreatite aguda — dor epigástrica intensa; sai por amilase < 3x LSN, ausência de pneumoperitônio e abdome em tábua.
- Isquemia mesentérica — dor intensa, mas desproporcional ao exame (aqui há peritonite franca).
- Diverticulite perfurada / apendicite perfurada — localização e evolução diferentes; pneumoperitônio pode ocorrer, mas o quadro epigástrico súbito e o AINE favorecem úlcera.
- IAM de parede inferior — dor epigástrica: solicitar ECG em pacientes com fatores de risco.

CONTEXTO CLÍNICO

A perfuração é a segunda complicação mais comum da doença ulcerosa péptica, com mortalidade de até 10–30%. AINEs, H. pylori e tabagismo são os principais fatores de risco.

JUSTIFICATIVA

Dor súbita, intensa, epigástrica, que se difunde; abdome em tábua, Blumberg positivo, sinal de Jobert e pneumoperitônio na radiografia em ortostatismo em paciente usando AINE com sintomas dispépticos prévios.

ANAMNESE ESPERADA

- Início súbito e evolução da dor
- Uso de AINE/corticoide
- Sintomas dispépticos prévios
- Tabagismo/etilismo
- Vômitos, sangramento

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Pesquisar irritação peritoneal (contratura, Blumberg)
- Percussão hepática (sinal de Jobert)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Radiografia de tórax PA em ortostatismo (rotina de abdome agudo)	Exame inicial mais rápido para pneumoperitônio (sensibilidade ~75–80%).	Pneumoperitônio.
TC de abdome	Se radiografia negativa e suspeita persistente (mais sensível).	Ar e líquido livre periduodenal.
Hemograma, eletrólitos, função renal, amilase/lipase, lactato, coagulograma, tipagem; ECG	Avaliação pré-operatória e diferenciais.	Leucocitose.

CONDUTA ESPERADA

- Jejum, sonda nasogástrica, hidratação venosa, analgesia, sonda vesical
- IBP EV em dose alta (ex.: omeprazol 40–80 mg EV 12/12 h)
- Antibiótico de amplo espectro (ex.: ceftriaxona + metronidazol)
- Suspender AINE

- Cirurgia de urgência: laparoscopia ou laparotomia com ulcerorrafia + epiploplastia (patch de omento de Graham) e lavagem da cavidade; biópsia da úlcera se gástrica
- Pós-operatório: pesquisar e erradicar H. pylori; manter IBP; cessação do tabagismo
- Tratamento não operatório (Taylor) apenas em casos muito selecionados

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar que houve “furo” no estômago/duodeno e a necessidade de cirurgia
- Obter consentimento

ERROS CRÍTICOS

- Solicitar endoscopia digestiva alta na suspeita de perfuração
- Não indicar tratamento cirúrgico
- Não iniciar antibiótico, IBP e jejum/SNG
- Dar alta com sintomáticos/antiácido

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-1 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor abdominal súbita “em facada” após uso de anti-inflamatório

CHECKLIST — ABDOME AGUDO PERFURATIVO

AVALIAÇÃO	Pts	Avaliação
Caracterizou a dor (súbita, epigástrica, difusa) e perguntou sobre uso de AINE e dispepsia prévia WSES Guidelines on Perforated Peptic Ulcer, 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou sinais de peritonite (abdome em tábua, Blumberg) e sinal de Jobert Sabiston, 21ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Solicitou radiografia de tórax PA em ortostatismo / rotina de abdome agudo WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou pneumoperitônio e diagnosticou abdome agudo perfurativo (úlcera péptica perfurada) WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Jejum, SNG, hidratação, analgesia, IBP EV WSES 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Antibiótico de amplo espectro WSES 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou cirurgia: ulcerorrafia + epiploplastia (Graham), laparoscópica ou aberta WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pós-operatório: erradicação de H. pylori e suspensão de AINE Consenso Brasileiro sobre H. pylori (IV), 2018	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-2 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Azia há anos que volta toda vez que para o remédio

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia do aparelho digestivo. Paciente encaminhada pelo gastroenterologista.

PACIENTE

Helena, 46 anos, sexo feminino, advogada.

QUEIXA PRINCIPAL

Azia e “comida voltando” há 4 anos; melhora com omeprazol, mas os sintomas retornam sempre que suspende. Deseja saber se pode operar.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese dirigida, incluindo sinais de alarme.
2. Indique os exames necessários antes de uma cirurgia antirrefluxo e interprete os resultados entregues.
3. Defina se há indicação cirúrgica e qual o procedimento.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-2 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Azia há anos que volta toda vez que para o remédio

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Peso	Altura	IMC
124/78 mmHg	70 bpm	14 irpm	66 kg	1,65 m	24,2 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, eutrófica.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: sem alterações
- OROFARINGE: sem alterações

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
pHmetria esofágica de 24 h (sem IBP há 7 dias)	**Tempo de exposição ácida 9,8%; DeMeester 42; boa correlação sintoma-refluxo**	Exposição ácida < 4%; DeMeester < 14,7
Manometria esofágica de alta resolução	**Peristalse normal (100% contrações efetivas); EEI hipotônico; sem distúrbio motor**	—

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (entregar se solicitada): esofagite erosiva Los Angeles grau B; hérnia hiatal por deslizamento de 3 cm; sem epitélio de Barrett; pesquisa de H. pylori negativa.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-2 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Azia há anos que volta toda vez que para o remédio

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. EDA, pHmetria e manometria SOMENTE se solicitadas. Se o candidato indicar a cirurgia sem solicitar manometria, ANOTAR como erro crítico.

PERFIL DO PACIENTE

Helena, 46 anos, advogada, não fuma, bebe vinho socialmente. Usa omeprazol 20 mg 2x/dia há 4 anos. Quer parar de depender de remédio e tem receio de efeitos de longo prazo.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, tenho uma azia horrível, sobe um líquido amargo na garganta, principalmente quando deito. Com o omeprazol melhora, mas é só parar que volta tudo.”
Sinais de alarme	“Não, não tenho dificuldade para engolir, não emagreci, nunca vomitei sangue nem tive fezes pretas.”
Sintomas atípicos	“Às vezes acordo tossindo à noite e fico rouca de manhã.”
Medidas comportamentais	“Já levantei a cabeceira da cama, não como antes de deitar, cortei café... ajuda um pouco.”
Pergunta ativa	“Se eu operar, vou ficar livre do remédio pra sempre? Tem algum risco?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Tosse noturna e rouquidão matinal — só revela se perguntada sobre sintomas extraesofágicos
- Uso diário de IBP há 4 anos com boa resposta — revela se perguntada sobre tratamento

COMPORTAMENTO DO ATOR

Objetiva, bem informada, um pouco ansiosa para operar. Faz perguntas diretas.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-2 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Azia há anos que volta toda vez que para o remédio

Doença do refluxo gastroesofágico erosiva (esofagite LA B) com hérnia hiatal por deslizamento de 3 cm, responsiva a IBP mas dependente de uso contínuo, com pHmetria positiva e manometria com peristalse normal — candidata a fundoplicatura laparoscópica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Acalasia — causa “regurgitação” e pode ser confundida com DRGE; a manometria normal a exclui (a fundoplicatura em acalasia seria desastrosa).
- Esofagite eosinofílica — disfagia/impactação, biópsias com eosinófilos; não presente.
- Pirose funcional / esôfago hipersensível — pHmetria normal; aqui a exposição ácida é patológica.
- Neoplasia de esôfago/estômago — afastada por ausência de sinais de alarme e EDA.

CONTEXTO CLÍNICO

A DRGE afeta 10–20% da população ocidental. A cirurgia antirrefluxo é indicada a pacientes com doença comprovada e boa resposta ao IBP que não desejam/não toleram tratamento contínuo, com refluxo volumoso, complicações ou hérnia hiatal grande.

JUSTIFICATIVA

Sintomas típicos (pirose e regurgitação) responsivos ao IBP + esofagite erosiva LA B + pHmetria com exposição ácida patológica. Manometria normal afasta distúrbio motor e orienta a técnica.

ANAMNESE ESPERADA

- Sintomas típicos (pirose, regurgitação) e atípicos (tosse, rouquidão, asma)
- Sinais de alarme: disfagia, odinofagia, perda de peso, anemia, hematêmese/melena, idade > 45–50 anos com sintomas novos
- Resposta ao IBP
- Medidas comportamentais

EXAME FÍSICO ESPERADO

Exame geral sem achados específicos; IMC (obesidade influencia técnica)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Endoscopia digestiva alta	Avaliar esofagite, Barrett, hérnia hiatal e excluir neoplasia.	Esofagite LA B, hérnia de 3 cm.
pHmetria (ou impedanciopHmetria) de 24 h sem IBP	Confirmar refluxo patológico quando não há esofagite grave (LA C/D) ou Barrett.	Exposição ácida 9,8%.
Manometria esofágica	OBRIGATÓRIA antes da fundoplicatura: excluir acalasia/aperistalse.	Peristalse normal.

CONDUTA ESPERADA

- Indicação de cirurgia: DRGE comprovada, boa resposta ao IBP, porém dependente de uso contínuo e desejo de não usar medicação por toda a vida
- Procedimento: hiatoplastia + fundoplicatura total laparoscópica (Nissen, 360°) — padrão com peristalse normal; fundoplicatura parcial (Toupet 270°) se hipomotilidade
- Alternativa: manter IBP na menor dose eficaz + medidas comportamentais
- Orientações: possíveis efeitos colaterais — disfagia transitória, incapacidade de eructar/vomitar, distensão gasosa (gas-bloat); recidiva em longo prazo (~10–20% podem voltar a usar IBP)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar de forma clara riscos e benefícios
- Decisão compartilhada
- Não prometer cura definitiva

ERROS CRÍTICOS

- Indicar fundoplicatura sem manometria esofágica
- Não pesquisar sinais de alarme
- Indicar cirurgia sem documentação objetiva de refluxo (EDA/pHmetria)
- Prometer que a paciente nunca mais precisará de medicação

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-2 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Azia há anos que volta toda vez que para o remédio

CHECKLIST — DRGE: AVALIAÇÃO PARA CIRURGIA

ANAMNESE	Pts	Avaliação
Caracterizou sintomas típicos e atípicos e resposta ao IBP Consenso de Lyon 2.0, 2023	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou sinais de alarme (disfagia, perda de peso, sangramento, anemia) Consenso Brasileiro de DRGE; ACG Guideline 2022	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

EXAMES	Pts	Avaliação
Solicitou EDA e interpretou (esofagite LA B, hérnia 3 cm) Consenso de Lyon 2.0	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou pHmetria 24 h e interpretou (exposição ácida > 6% = patológica) Consenso de Lyon 2.0	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou manometria esofágica antes da cirurgia (excluir acalasia) SAGES Guidelines for GERD, 2021	2	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Reconheceu indicação cirúrgica (dependência de IBP, doença comprovada) SAGES 2021; ACG 2022	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou hiatoplastia + fundoplicatura laparoscópica (Nissen) e citou Toupet se hipomotilidade SAGES 2021	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou efeitos adversos (disfagia, gas-bloat) e possibilidade de recidiva SAGES 2021	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-3 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Dificuldade para engolir que piora a cada semana

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia. Consulta de primeira vez.

PACIENTE

Valdir, 63 anos, sexo masculino, ex-garçom.

QUEIXA PRINCIPAL

Dificuldade para engolir há 3 meses, primeiro com carne e pão, e agora até com alimentos pastosos, com emagrecimento.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese dirigida.
2. Formule a hipótese diagnóstica e solicite a investigação diagnóstica e de estadiamento.
3. Cite a conduta terapêutica geral e as medidas de suporte.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-3 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Dificuldade para engolir que piora a cada semana

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura	IMC
118/72 mmHg	86 bpm	16 irpm	36,4 °C	58 kg (há 3 meses: 68 kg)	1,72 m	19,6 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Emagrecido, hipocorado 1+/4+, hidratado.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- PESCOÇO: sem linfonodomegalias; linfonodo supraclavicular esquerdo não palpável
- ABDOME: escavado, sem massas ou visceromegalias
- ORAL: dentes em mau estado de conservação

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemoglobina	**10,8 g/dL**	13–17 g/dL
Albumina	**3,0 g/dL**	3,5–5,0 g/dL

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (entregar se solicitada): lesão vegetante e ulcerada, friável, a 28–33 cm da arcada dentária superior (terço médio do esôfago), ocupando 2/3 da circunferência e reduzindo a luz, transposta com dificuldade pelo aparelho. Biópsias: CARCINOMA ESPINOCELULAR moderadamente diferenciado.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-3 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Dificuldade para engolir que piora a cada semana

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. EDA com biópsia SOMENTE se solicitada. Se o candidato pedir apenas esofagograma (RX contrastado), entregar: “estenose irregular em terço médio, aspecto em maçã mordida” e perguntar: “e para confirmação diagnóstica?”.

PERFIL DO PACIENTE

Valdir, 63 anos, ex-garçom, fuma 1 maço/dia há 45 anos, bebe cachaça diariamente há 30 anos. Toma chimarrão muito quente desde a infância (gaúcho).

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, a comida tá agarrando aqui no meio do peito. Primeiro era só carne, agora até sopa grossa tem que ser devagar.”
Perda de peso	“Perdi uns dez quilos nesses três meses.”
Dor / regurgitação	“Às vezes a comida volta. Dói um pouco quando engulo.”
Hábitos	“Fumo desde os 18 anos, um maço por dia. E tomo minha cachacinha todo dia.”
Rouquidão / tosse ao comer	“Rouco não tô. Tosse quando como não.”
Pergunta ativa	“É câncer, doutor? Tem como operar?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Chimarrão muito quente diariamente — só revela se perguntado sobre bebidas quentes/hábitos alimentares
- Sem azia crônica (afasta Barrett/adenocarcinoma) — revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Preocupado, desconfiado de que é algo grave. Fica abalado se o candidato for abrupto.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-3 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Dificuldade para engolir que piora a cada semana

Carcinoma espinocelular de esôfago torácico médio, com disfagia progressiva e desnutrição (perda > 10% do peso em 3 meses), em tabagista e etilista — estadiamento a definir.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Adenocarcinoma de esôfago — mais comum no terço distal, associado a DRGE/Barrett e obesidade; a biópsia define CEC.
- Estenose péptica — história de refluxo crônico, disfagia sem perda de peso importante.
- Acalasia — disfagia para sólidos e líquidos desde o início, longa evolução.
- Compressão extrínseca (linfonodos, tumor pulmonar) — avaliada na TC.

CONTEXTO CLÍNICO

O CEC é o tipo histológico mais comum de câncer de esôfago no Brasil, associado a tabagismo, etilismo e ingestão de bebidas muito quentes (chimarrão), com maior incidência no Sul. Disfagia progressiva com perda de peso é o sintoma cardinal e geralmente indica doença localmente avançada.

JUSTIFICATIVA

Disfagia progressiva (sólidos → pastosos), perda ponderal, fatores de risco (tabaco, álcool, chimarrão) e EDA com lesão vegetante em terço médio com biópsia de CEC.

ANAMNESE ESPERADA

- Padrão de progressão da disfagia
- Perda de peso
- Odinofagia, regurgitação
- Rouquidão, tosse ao deglutir (fístula traqueoesofágica, invasão do nervo laríngeo recorrente)
- Tabagismo, etilismo, bebidas quentes
- Azia crônica

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Estado nutricional
- Linfonodos cervicais e supraclaviculares
- Hepatomegalia

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Endoscopia digestiva alta com biópsia	Diagnóstico histológico (obrigatória).	CEC de terço médio.
TC de tórax e abdome (± pescoço) com contraste	Estadiamento: metástases a distância, linfonodos, invasão local.	—
PET-CT	Detectar metástases ocultas em candidatos a tratamento curativo.	—
Ecoendoscopia	Estadiamento T e N locorregional (se não houver metástase).	—
Broncoscopia (tumores de terço médio/superior) e avaliação otorrinolaringológica	Invasão da via aérea e tumores sincrônicos de cabeça e pescoço (cancerização de campo).	—

CONDUTA ESPERADA

- Suporte nutricional prioritário: avaliação nutricional, dieta adaptada, suplementação; se ingesta insuficiente — sonda nasoenteral ou gastrostomia/jejunostomia (evitar comprometer o estômago para

reconstrução)
- Discussão em equipe multidisciplinar (tumor board)
- Doença localmente avançada ressecável (T2–T4a e/ou N+): quimiorradioterapia neoadjuvante (esquema CROSS: carboplatina + paclitaxel + 41,4 Gy) seguida de esofagectomia; no CEC, quimiorradioterapia definitiva é alternativa
- Tumor precoce (T1a): ressecção endoscópica
- Doença metastática: paliação — prótese esofágica, radioterapia, quimioterapia/imunoterapia
- Cessação do tabagismo e etilismo

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar a suspeita/diagnóstico com empatia (SPIKES)
- Explicar a necessidade de estadiamento antes de definir a cirurgia
- Abordar o estado nutricional

ERROS CRÍTICOS

- Tratar como DRGE (prescrever IBP) sem solicitar endoscopia
- Não solicitar biópsia (confiar apenas no esofagograma)
- Indicar esofagectomia imediata sem estadiamento
- Não abordar suporte nutricional

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-3 · Ambulatório — Cirurgia do Aparelho Digestivo · nível moderado

Dificuldade para engolir que piora a cada semana

CHECKLIST — CÂNCER DE ESÔFAGO

ANAMNESE	Pts	Avaliação
Caracterizou a disfagia (progressiva, sólidos → pastosos) e quantificou a perda de peso INCA — Câncer de Esôfago	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou fatores de risco (tabaco, álcool, bebidas quentes, DRGE/Barrett) INCA; NCCN Esophageal Cancer, 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou rouquidão/tosse ao deglutir (invasão local/fístula) Sabiston, 21ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO	Pts	Avaliação
Hipótese de neoplasia de esôfago (CEC pelo perfil de risco) NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou EDA com biópsia NCCN 2024	2	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou TC de tórax/abdome ± PET-CT e ecoendoscopia para estadiamento NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou broncoscopia e/ou avaliação de cabeça e pescoço NCCN 2024	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Priorizou suporte nutricional (via enteral se necessário) ESPEN Guideline on Cancer Patients, 2021	1	☐ A ☐ P ☐ I
Citou neoadjuvância (QRT — CROSS) + esofagectomia ou QRT definitiva, discutido em equipe multidisciplinar van Hagen et al., CROSS, NEJM 2012	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-4 · Ambulatório — Cirurgia Geral · nível fácil

Caroço na virilha que aparece ao fazer força

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia geral.

PACIENTE

Edson, 52 anos, sexo masculino, carregador em depósito de materiais de construção.

QUEIXA PRINCIPAL

Abaulamento na virilha direita há 6 meses, que aparece quando faz força e some quando deita, com desconforto no fim do dia.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o exame físico da região inguinal, verbalizando as manobras (achados fornecidos mediante solicitação).
2. Formule o diagnóstico e os diferenciais.
3. Proponha a conduta e oriente sinais de alarme.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-4 · Ambulatório — Cirurgia Geral · nível fácil

Caroço na virilha que aparece ao fazer força

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Peso	Altura	IMC
128/82 mmHg	72 bpm	14 irpm	80 kg	1,74 m	26,4 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- REGIÃO INGUINAL DIREITA — PACIENTE EM PÉ: abaulamento de 4 cm acima do ligamento inguinal, que aumenta à manobra de Valsalva/tosse e desce em direção ao escroto
- PALPAÇÃO PELO ANEL INGUINAL EXTERNO (invaginando a pele do escroto com o dedo): impulso sentido na POLPA do dedo à tosse
- REDUTIBILIDADE: em decúbito dorsal, o conteúdo reduz-se espontaneamente; indolor
- ESCROTO: testículos tópicos, sem massas; transiluminação negativa
- REGIÃO INGUINAL ESQUERDA: sem abaulamento
- REGIÃO FEMORAL: sem abaulamento abaixo do ligamento inguinal

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-4 · Ambulatório — Cirurgia Geral · nível fácil

Caroço na virilha que aparece ao fazer força

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Os achados só são fornecidos se o candidato verbalizar: exame em pé E deitado, manobra de Valsalva/tosse, palpação pelo anel inguinal externo, avaliação de redutibilidade, exame do lado contralateral e da região femoral. Se o candidato pedir USG, informar que “não é necessária para o diagnóstico neste caso”.

PERFIL DO PACIENTE

Edson, 52 anos, carregador há 20 anos. Não fuma. Sem tosse crônica, sem constipação, sem dificuldade urinária.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, tem um caroço na virilha direita que estufa quando eu pego peso, e quando eu deito ele some.”
Dor	“Incomoda no fim do dia, um peso. Mas não é dor forte.”
Episódio de não redução	“Uma vez ele ficou um tempinho sem voltar, mas aí deitei e voltou sozinho.”
Fatores de esforço abdominal	“Tosse crônica eu não tenho. Intestino funciona bem. Urino normal.”
Pergunta ativa	“Precisa operar? Posso continuar trabalhando carregando peso?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Um episódio em que a hérnia ficou alguns minutos sem reduzir — só revela se perguntado se o caroço já “travou”/não voltou
- Trabalha carregando sacos de cimento — revela se perguntado sobre a profissão

COMPORTAMENTO DO ATOR

Colaborativo, preocupado com o afastamento do trabalho.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-4 · Ambulatório — Cirurgia Geral · nível fácil

Caroço na virilha que aparece ao fazer força

Hérnia inguinal direita redutível, sintomática, provavelmente indireta (impulso na polpa do dedo, trajeto em direção ao escroto) — não complicada.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Hérnia inguinal direta — impulso na lateral do dedo; abaulamento mais medial e arredondado; distinção clínica é pouco precisa e não muda a conduta.
- Hérnia femoral — abaulamento ABAIXO do ligamento inguinal, mais comum em mulheres; alto risco de encarceramento.
- Hidrocele / cisto de cordão — transiluminação positiva, não redutível, não varia com Valsalva.
- Linfonodomegalia inguinal / varicocele / lipoma de cordão — não reduzem e não têm impulso à tosse.

CONTEXTO CLÍNICO

Hérnias inguinais representam ~75% das hérnias de parede, com predomínio em homens (risco ao longo da vida de 27%). A hérnia indireta é a mais comum em ambos os sexos.

JUSTIFICATIVA

Abaulamento acima do ligamento inguinal, redutível, que aumenta com Valsalva, com impulso à tosse palpado pelo anel inguinal externo.

ANAMNESE ESPERADA

- Tempo de evolução, dor, redutibilidade
- Episódios de encarceramento
- Fatores de aumento da pressão abdominal (tosse crônica, constipação, prostatismo, esforço físico)
- Ocupação

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Exame em pé e deitado
- Valsalva/tosse
- Palpação pelo anel inguinal externo
- Redutibilidade
- Exame contralateral, região femoral e escroto

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Diagnóstico clínico	Exame de imagem só se dúvida diagnóstica (USG; RM se dor inguinal oculta).	—
Exames pré-operatórios conforme idade/comorbidades	Avaliação de risco cirúrgico.	—

CONDUTA ESPERADA

- Hernioplastia inguinal eletiva com tela: técnica de Lichtenstein (aberta) ou laparoscópica (TEP/TAPP) — homem sintomático tem indicação cirúrgica (conduta expectante só para homens assintomáticos/oligossintomáticos)
- Orientações: sinais de encarceramento/estrangulamento — dor intensa, abaulamento que não reduz, vermelhidão, vômitos, parada de eliminação de fezes/flatos → procurar PS imediatamente
- Retorno às atividades: atividades leves precoces; esforço intenso em ~2–4 semanas conforme tolerância
- NÃO usar funda como tratamento definitivo

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o que é hérnia e por que operar

- Orientar sinais de alarme
- Abordar o retorno ao trabalho

ERROS CRÍTICOS

- Não examinar o paciente em ortostatismo
- Não orientar sinais de encarceramento/estrangulamento
- Indicar funda/“cinta” como tratamento definitivo
- Não diferenciar de hérnia femoral (examinar abaixo do ligamento inguinal)

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-4 · Ambulatório — Cirurgia Geral · nível fácil

Caroço na virilha que aparece ao fazer força

CHECKLIST — HÉRNIA INGUINAL

EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Examinou em pé e deitado, com manobra de Valsalva/tosse HerniaSurge Group — International Guidelines, 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Palpou pelo anel inguinal externo e avaliou redutibilidade HerniaSurge 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Examinou lado contralateral, região femoral e escroto HerniaSurge 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou hérnia inguinal direita redutível (citou provável indireta) Sabiston, 21ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou diferenciais (femoral, hidrocele, linfonodo) Sabiston, 21ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou sobre fatores de aumento da pressão abdominal e episódios de encarceramento HerniaSurge 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou hernioplastia eletiva com tela (Lichtenstein ou laparoscópica) HerniaSurge 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou sinais de encarceramento/estrangulamento HerniaSurge 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-5 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada

CENÁRIO

Pronto-socorro, domingo à noite.

PACIENTE

Sandra, 44 anos, sexo feminino, cabeleireira.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor em lado direito da barriga há 20 horas, iniciada após almoço com feijoada, com febre e vômitos.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o exame físico abdominal dirigido, verbalizando as manobras (achados mediante solicitação).
2. Interprete os exames, formule o diagnóstico e classifique a gravidade (Tóquio 2018).
3. Proponha a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-5 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso	Altura	IMC
126/80 mmHg	102 bpm	18 irpm	38,3 °C	74 kg	1,62 m	28,2 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, anictérica, desidratada 1+/4+.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: plano, ruídos hidroaéreos presentes, dor à palpação em hipocôndrio direito com defesa localizada; SINAL DE MURPHY POSITIVO (interrupção da inspiração profunda à palpação do ponto cístico); sem massa palpável; sem sinais de peritonite difusa; sem dor em fossa ilíaca direita
- Giordano negativo

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Leucócitos	**14.500/mm³**	4.000–11.000/mm³
PCR	**68 mg/L**	< 5 mg/L
Bilirrubina total	0,9 mg/dL	< 1,2 mg/dL
Fosfatase alcalina / GGT	110 / 58 U/L	< 120 / < 50 U/L
AST / ALT	32 / 38 U/L	< 40 U/L
Lipase	42 U/L	< 60 U/L
Creatinina / plaquetas / INR	0,8 mg/dL / 260.000 / 1,0	Normais

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME (entregar se solicitada): vesícula biliar distendida, parede espessada (5 mm) com aspecto em dupla camada, cálculo de 2 cm impactado no infundíbulo, pequena lâmina de líquido perivesicular; sinal de Murphy ultrassonográfico positivo. Vias biliares intra e extra-hepáticas não dilatadas (colédoco 4 mm).

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-5 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início; exame físico, exames laboratoriais e USG SOMENTE se solicitados. Se o candidato indicar CPRE, ANOTAR como conduta inadequada (sem indicação).

PERFIL DO PACIENTE

Sandra, 44 anos, cabeleireira, 3 filhos, sobrepeso. Já teve episódios de dor após comida gordurosa que passavam em poucas horas. Sem comorbidades.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Comecei com uma dor aqui do lado direito depois da feijoada de ontem. Dessa vez não passou, e tô com febre.”
Episódios prévios	“Já tive essa dor outras vezes, depois de comer gordura, mas passava em duas, três horas.”
Irradiação	“Às vezes vai pras costas, pro ombro direito.”
Icterícia / urina	“Não fiquei amarela, e a urina tá normal.”
Pergunta ativa	“É pedra na vesícula? Dá pra só tomar remédio e operar depois, nas férias?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Episódios prévios de cólica biliar autolimitados — só revela se perguntada sobre dor semelhante antes
- Quer adiar a cirurgia para as férias (daqui a 3 meses) — revela na pergunta ativa

COMPORTAMENTO DO ATOR

Incomodada pela dor, colaborativa; resiste à ideia de operar agora por causa do salão.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-5 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada

Colecistite aguda litiásica, grau I (leve) pela classificação de Tóquio 2018, sem coledocolitíase.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Cólica biliar — dor < 6 h, sem febre, leucocitose ou sinais inflamatórios na USG.
- Colangite aguda — febre + icterícia + dor (tríade de Charcot); bilirrubinas e via biliar normais aqui.
- Pancreatite aguda biliar — lipase normal.
- Apendicite retrocecal / pielonefrite direita / úlcera péptica — afastadas pelo exame e USG.

CONTEXTO CLÍNICO

A colecistite aguda é a complicação mais comum da colelitíase (obstrução do ducto cístico). Tóquio 2018: diagnóstico = sinal local (Murphy, dor/massa em HCD) + sinal sistêmico (febre, PCR, leucocitose) + imagem característica.

JUSTIFICATIVA

Murphy positivo + febre, leucocitose e PCR elevada + USG com parede espessada, cálculo impactado, líquido perivesicular e Murphy ultrassonográfico = diagnóstico definitivo. Grau I: sem disfunção orgânica (grau III) e sem leucócitos > 18.000, massa palpável, evolução > 72 h ou inflamação local grave (grau II).

ANAMNESE ESPERADA

- Características e duração da dor (> 6 h)
- Febre, vômitos
- Episódios prévios de cólica biliar
- Icterícia, colúria, acolia
- Comorbidades

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação do hipocôndrio direito
- Sinal de Murphy
- Pesquisa de massa e peritonite
- Pesquisa de icterícia

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Ultrassonografia de abdome	Exame de escolha para colecistite.	Sinais de colecistite aguda.
Hemograma, PCR, bilirrubinas, FA/GGT, transaminases, lipase, função renal, coagulograma	Gravidade (Tóquio) e afastar coledocolitíase/pancreatite.	Leucocitose e PCR elevadas; restante normal.

CONDUTA ESPERADA

- Internação, jejum inicial, hidratação venosa, analgesia (dipirona; AINE como cetoprofeno; opioide se necessário), antiemético
- Antibiótico: ex.: ceftriaxona + metronidazol ou amoxicilina-clavulanato/ampicilina-sulbactam (em grau I, pode ser suspenso após a cirurgia)
- Colecistectomia videolaparoscópica PRECOCE, na mesma internação, idealmente nas primeiras 72 h (até 7–10 dias do início dos sintomas)
- CPRE não indicada (sem coledocolitíase)
- Explicar que adiar a cirurgia aumenta risco de recorrência e complicações

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o diagnóstico e a necessidade de cirurgia nesta internação
- Negociar com empatia a preocupação com o trabalho

ERROS CRÍTICOS

- Dar alta com analgésico e cirurgia eletiva ambulatorial
- Não pesquisar o sinal de Murphy / não solicitar USG
- Indicar CPRE sem evidência de coledocolitíase/colangite
- Não prescrever antibiótico

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-5 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor do lado direito da barriga com febre após feijoada

CHECKLIST — COLECISTITE AGUDA

EXAME E DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Pesquisou o sinal de Murphy e sinais de peritonite/icterícia Tokyo Guidelines 2018 (TG18)	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou USG de abdome e interpretou os achados TG18	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Diagnosticou colecistite aguda litiásica (critérios A + B + C de Tóquio) TG18	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Classificou como grau I (leve) TG18	1	☐ A ☐ P ☐ I
Afastou coledocolitíase/colangite e pancreatite (bilirrubinas, enzimas, lipase) TG18	1	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Internação, hidratação, analgesia e antibiótico TG18; WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou colecistectomia videolaparoscópica precoce na mesma internação TG18; WSES Acute Calculous Cholecystitis, 2020	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-6 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor forte em faixa na parte de cima da barriga

CENÁRIO

Pronto-socorro, 8h.

PACIENTE

Lúcia, 56 anos, sexo feminino, costureira.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor intensa em parte superior do abdome, em faixa, irradiando para as costas, há 10 horas, com vômitos.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Com base nos dados fornecidos, estabeleça o diagnóstico (justificando os critérios) e a provável etiologia.
2. Avalie a gravidade.
3. Prescreva a conduta inicial e defina o tratamento da causa.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-6 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor forte em faixa na parte de cima da barriga

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
128/78 mmHg	104 bpm	20 irpm	37,6 °C	96%	70 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Regular estado geral, desidratada 2+/4+, anictérica, lúcida.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

ABDOME: discretamente distendido, ruídos hidroaéreos diminuídos, dor à palpação em epigástrio e hipocôndrios, sem descompressão brusca dolorosa; sem equimoses periumbilical (Cullen) ou em flancos (Grey-Turner)

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Lipase	**2.150 U/L**	< 60 U/L
Leucócitos	**13.200/mm³**	4.000–11.000/mm³
Hematócrito	44%	36–46%
Ureia / creatinina	38 / 0,9 mg/dL	< 40 / < 1,1 mg/dL
ALT / AST	**312 / 260 U/L**	< 40 U/L
Bilirrubina total	**1,6 mg/dL**	< 1,2 mg/dL
Triglicerídeos / cálcio	160 mg/dL / 9,2 mg/dL	< 150 / 8,5–10,5
Gasometria arterial	pH 7,38; PaO_2 88 mmHg	Normal

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME (entregar se solicitada): vesícula com múltiplos cálculos pequenos (3–5 mm), parede fina; colédoco de 6 mm sem cálculos visíveis; pâncreas parcialmente visualizado por interposição gasosa, aumentado de volume.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-6 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor forte em faixa na parte de cima da barriga

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais, exame físico e exames laboratoriais no início. USG somente se solicitada. Se o candidato pedir TC de abdome na admissão, informar: “Por que o senhor quer a TC agora?” — aceitar apenas se justificar dúvida diagnóstica. Se prescrever antibiótico profilático, ANOTAR como erro.

PERFIL DO PACIENTE

Lúcia, 56 anos, costureira, não bebe álcool, não fuma. Sabe que tem “pedra na vesícula” há 2 anos, aguardando cirurgia.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Uma dor muito forte aqui em cima, como uma faixa, que vai pras costas. Já vomitei várias vezes.”
Álcool	“Não bebo nada, doutor.”
Vesícula	“Descobri que tinha pedra na vesícula faz dois anos, mas a cirurgia nunca saiu.”
Pergunta ativa	“Vou ter que ficar sem comer muitos dias? Vão tirar a vesícula?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

Colelitíase conhecida aguardando cirurgia há 2 anos — só revela se perguntada sobre vesícula/doenças prévias

COMPORTAMENTO DO ATOR

Com dor, encurvada para frente (posição de alívio), colaborativa.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-6 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor forte em faixa na parte de cima da barriga

Pancreatite aguda de etiologia biliar, forma LEVE (Atlanta revisada — sem falência orgânica ou complicações locais), BISAP 1, sem colangite.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Úlcera péptica perfurada — dor súbita, abdome em tábua, pneumoperitônio; lipase pode subir, mas não > 3x.
- Colecistite aguda — Murphy positivo e sinais inflamatórios na vesícula; lipase normal.
- Colangite aguda — febre, icterícia e dor; exigiria CPRE urgente — não há critérios aqui.
- IAM inferior / isquemia mesentérica — considerar em idosos com fatores de risco.

CONTEXTO CLÍNICO

Litíase biliar e álcool respondem por ~70–80% das pancreatites agudas. A maioria (~80%) é leve e autolimitada. Elevação de ALT > 150 U/L nas primeiras 48 h tem alto valor preditivo positivo para etiologia biliar.

JUSTIFICATIVA

Critérios de Atlanta (2 de 3): dor típica (epigástrica em faixa, irradiada para o dorso) + lipase > 3x o LSN (2.150) → diagnóstico sem necessidade de TC. Etiologia biliar: colelitíase, ALT > 150, ausência de etilismo, TG e cálcio normais. Gravidade: sem falência orgânica (PaO_2, creatinina, PA normais) → leve. BISAP = 1 ponto (SIRS presente: FC > 90 e leucócitos > 12.000; ureia normal, sem alteração mental, idade < 60, sem derrame pleural) — escore < 3 = baixo risco de mortalidade.

ANAMNESE ESPERADA

- Características da dor
- Etilismo
- Colelitíase conhecida
- Medicamentos
- Hipertrigliceridemia
- Procedimentos recentes (CPRE)

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Sinais de gravidade (Cullen, Grey-Turner, desidratação, irritação peritoneal)
- Icterícia

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Lipase (ou amilase)	Diagnóstico (> 3x LSN).	2.150 U/L.
USG de abdome	Pesquisar etiologia biliar em todos os pacientes.	Colelitíase.
Ureia, creatinina, hematócrito, gasometria, cálcio, triglicerídeos, função hepática	Gravidade (BISAP, Marshall) e etiologia.	Sem falência orgânica.
TC com contraste	NÃO rotineira na admissão; indicar se dúvida diagnóstica ou após 72–96 h se não houver melhora (avaliar necrose).	—

CONDUTA ESPERADA

- Hidratação venosa com Ringer lactato, de forma MODERADA e guiada por metas (ex.: bolus de 10 mL/kg se hipovolemia, seguido de 1,5 mL/kg/h; reavaliar em 12–24 h — evitar hidratação agressiva, estudo

WATERFALL)
- Analgesia (dipirona; opioide se necessário) e antiemético
- Dieta oral precoce (em 24–48 h, conforme tolerância), sem jejum prolongado
- SEM antibiótico profilático
- Monitorização de diurese e sinais vitais
- Tratamento da causa: colecistectomia videolaparoscópica NA MESMA INTERNAÇÃO, após melhora clínica, na pancreatite biliar leve (estudo PONCHO)
- CPRE apenas se colangite associada ou obstrução biliar persistente

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o diagnóstico e a relação com os cálculos
- Explicar que a vesícula será retirada antes da alta para evitar novas crises

ERROS CRÍTICOS

- Prescrever antibiótico profilático na pancreatite leve
- Solicitar TC de rotina na admissão sem dúvida diagnóstica
- Não indicar colecistectomia na mesma internação
- Indicar CPRE de rotina sem colangite
- Manter jejum prolongado/nutrição parenteral sem indicação

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-6 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor forte em faixa na parte de cima da barriga

CHECKLIST — PANCREATITE AGUDA BILIAR

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou pancreatite aguda pelos critérios de Atlanta (dor típica + lipase > 3x) Atlanta Revisada, Gut 2013	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou etiologia biliar (colelitíase, ALT > 150, sem etilismo, TG e cálcio normais) ACG Guideline Acute Pancreatitis, 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Classificou gravidade como leve (sem falência orgânica) e citou escore (BISAP/Marshall) Atlanta 2013	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA INICIAL	Pts	Avaliação
Hidratação com Ringer lactato moderada e guiada por metas de-Madaria et al., WATERFALL, NEJM 2022	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Analgesia e dieta oral precoce ACG 2024; IAP/APA 2013	1	☐ A ☐ P ☐ I
Não prescreveu antibiótico profilático e não pediu TC de rotina ACG 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO DA CAUSA	Pts	Avaliação
Indicou colecistectomia na mesma internação da Costa et al., PONCHO, Lancet 2015	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Restringiu CPRE à colangite/obstrução persistente ACG 2024	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-7 · Ambulatório — Coloproctologia · nível fácil

Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus

CENÁRIO

Ambulatório de coloproctologia.

PACIENTE

Márcio, 52 anos, sexo masculino, motorista de ônibus.

QUEIXA PRINCIPAL

Sangramento vermelho vivo ao evacuar e “bolinha” que sai pelo ânus durante a evacuação há 1 ano.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese dirigida e descreva o exame proctológico a ser realizado (achados fornecidos mediante solicitação).
2. Formule o diagnóstico e classifique.
3. Proponha o tratamento e a investigação complementar.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-7 · Ambulatório — Coloproctologia · nível fácil

Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Peso	Altura	IMC
132/84 mmHg	76 bpm	14 irpm	90 kg	1,75 m	29,4 kg/m²

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, corado.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- INSPEÇÃO ANAL (em posição de Sims/genupeitoral, com consentimento e acompanhante): sem fissuras, sem fístulas, plicomas discretos; ao esforço evacuatório: prolapso de mamilos hemorroidários internos
- TOQUE RETAL: esfíncter normotônico, sem massas palpáveis, sem dor; dedo de luva com fezes normais, sem sangue
- ANUSCOPIA: mamilos hemorroidários internos congestos às 3, 7 e 11 horas, com prolapso que retorna somente com REDUÇÃO MANUAL (conforme relato)

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemoglobina	13,8 g/dL	13–17 g/dL

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-7 · Ambulatório — Coloproctologia · nível fácil

Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Achados do exame proctológico SOMENTE se o candidato descrever inspeção, toque retal e anuscopia, pedindo consentimento e acompanhante. Se o candidato perguntar sobre colonoscopia prévia: “nunca fez”.

PERFIL DO PACIENTE

Márcio, 52 anos, motorista de ônibus, passa 10 h sentado, come pouca fibra, bebe pouca água, intestino preso (evacua a cada 3 dias com esforço). Pai faleceu de câncer de intestino aos 70 anos.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, quando eu evacuo sai sangue vermelhinho, pinga no vaso. E sai uma bolinha que eu tenho que empurrar de volta com o dedo.”
Dor	“Dor não tenho, só um incômodo e coceira.”
Hábito intestinal	“Meu intestino é preso, vou a cada três dias, e faço muita força.”
Alimentação	“Como muito na rua, quase nada de verdura. Água eu bebo pouco, por causa do trabalho.”
Perda de peso / mudança do hábito	“Não perdi peso. O intestino sempre foi assim.”
Pergunta ativa	“Isso é hemorroida? Tem que operar? Tenho medo, dizem que dói muito.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Pai com câncer colorretal aos 70 anos — só revela se perguntado sobre história familiar
- Nunca fez colonoscopia — revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Envergonhado, reticente ao exame; aceita se o candidato explicar e pedir consentimento com respeito.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-7 · Ambulatório — Coloproctologia · nível fácil

Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus

Doença hemorroidária interna grau III (Goligher — prolapso com redução manual), sintomática (sangramento e prolapso), associada a constipação e hábitos alimentares inadequados; necessidade de colonoscopia (≥ 45 anos, sangramento e história familiar).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Câncer colorretal — sangramento retal em > 45 anos com história familiar: excluir com colonoscopia.
- Fissura anal — dor intensa à evacuação; não presente.
- Prolapso retal — prolapso de toda a parede, com pregas concêntricas.
- Pólipos/papila hipertrófica — avaliados pela anuscopia/colonoscopia.

CONTEXTO CLÍNICO

A doença hemorroidária é muito prevalente e associada a constipação, esforço evacuatório, baixa ingestão de fibras e permanência sentado. O sangramento nunca deve ser atribuído às hemorroidas sem excluir neoplasia quando há fatores de risco.

JUSTIFICATIVA

Sangramento vermelho vivo indolor ao final da evacuação + prolapso que exige redução manual + anuscopia com mamilos internos = hemorroidas internas grau III.

ANAMNESE ESPERADA

- Características do sangramento
- Prolapso e forma de redução
- Dor (diferenciar fissura/trombose)
- Hábito intestinal, alimentação e ingesta hídrica
- Sinais de alarme: perda de peso, alteração do hábito, anemia
- História familiar de CCR e colonoscopia prévia

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Consentimento e acompanhante
- Inspeção (repouso e esforço)
- Toque retal
- Anuscopia

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Colonoscopia	Sangramento retal em ≥ 45 anos e história familiar de CCR — excluir neoplasia antes de tratar as hemorroidas.	—
Hemograma	Avaliar anemia.	Normal.

CONDUTA ESPERADA

- Medidas higienodietéticas para todos: fibras 25–35 g/dia (ou psyllium), ingesta hídrica ≥ 2 L/dia, evitar esforço evacuatório e permanência prolongada no vaso, banho de assento morno
- Flebotônicos (diosmina + hesperidina) como adjuvante nas crises
- Grau III: ligadura elástica ambulatorial pode ser tentada; hemorroidectomia (Milligan-Morgan/Ferguson) se falha, grau III volumoso/misto ou grau IV
- Colonoscopia ANTES do tratamento definitivo
- Analgesia pós-operatória multimodal (abordar o medo da dor)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Pedir consentimento para o exame, garantir privacidade e acompanhante

- Explicar diagnóstico e opções
- Explicar a necessidade de colonoscopia sem alarmar

ERROS CRÍTICOS

- Atribuir o sangramento às hemorroidas sem toque retal/anuscopia
- Não indicar colonoscopia em paciente ≥ 45 anos com sangramento e história familiar
- Realizar exame proctológico sem consentimento
- Não orientar medidas higienodietéticas

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-7 · Ambulatório — Coloproctologia · nível fácil

Sangue vivo nas fezes e “bolinha” que sai do ânus

CHECKLIST — DOENÇA HEMORROIDÁRIA

ANAMNESE E EXAME	Pts	Avaliação
Caracterizou sangramento e prolapso (forma de redução) ASCRS Clinical Practice Guidelines — Hemorrhoids, 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Investigou hábito intestinal, dieta e sinais de alarme ASCRS 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Perguntou história familiar de CCR e colonoscopia prévia SBCP; USPSTF 2021	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pediu consentimento e descreveu inspeção, toque retal e anuscopia ASCRS 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou hemorroidas internas grau III (Goligher) Classificação de Goligher	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Orientou medidas higienodietéticas (fibras, água, evitar esforço, banho de assento) ASCRS 2018	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou ligadura elástica e/ou hemorroidectomia conforme grau ASCRS 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou colonoscopia antes do tratamento definitivo ASCRS 2018; SBCP	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-8 · Ambulatório — Retorno pós-operatório · nível difícil

Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia geral. Retorno de pós-operatório.

PACIENTE

Dona Conceição, 68 anos, sexo feminino, aposentada. Colecistectomia videolaparoscópica há 15 dias por colelitíase sintomática (cálculo de 3,5 cm), sem intercorrências.

QUEIXA PRINCIPAL

Retorna para retirada de pontos e para receber o resultado do exame anatomopatológico.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete o laudo anatomopatológico e comunique o resultado à paciente.
2. Indique os próximos passos diagnósticos e terapêuticos.
3. Cite os fatores de risco para câncer de vesícula e diferencie da apresentação do colangiocarcinoma.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-8 · Ambulatório — Retorno pós-operatório · nível difícil

Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso
134/80 mmHg	74 bpm	14 irpm	36,2 °C	62 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, anictérica, corada.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: incisões de trocarte cicatrizadas, sem sinais de infecção; flácido, indolor, sem massas ou visceromegalias
- LINFONODOS: sem linfonodomegalia supraclavicular ou periumbilical

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

LAUDO ANATOMOPATOLÓGICO (entregar no início): vesícula biliar com colecistite crônica e colelitíase; ADENOCARCINOMA moderadamente diferenciado em fundo vesicular, invadindo o tecido conjuntivo perimuscular, sem ultrapassar a serosa (lado peritoneal) — pT2a; margem do ducto cístico livre; linfonodo cístico sem neoplasia (0/1).

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-8 · Ambulatório — Retorno pós-operatório · nível difícil

Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias

NOTA AO AVALIADOR

Entregar o laudo no início. A paciente veio sozinha esperando “só tirar os pontos”. Avaliar se o candidato utiliza técnica de comunicação de más notícias (SPIKES): ambiente, percepção, convite, conhecimento, emoções, estratégia. Se o candidato indicar “apenas acompanhamento”, ANOTAR como erro crítico.

PERFIL DO PACIENTE

Conceição, 68 anos, viúva, 3 filhos, mora com uma filha. Tinha “pedra na vesícula” há mais de 10 anos e adiou a cirurgia várias vezes. Está aliviada porque “a dor passou”.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Abertura	“Bom dia, doutor! Tô ótima, a dor sumiu. Vim só tirar esses pontinhos e pegar o resultado.”
O que sabe sobre o exame	“O médico disse que ia mandar a vesícula pra análise, mas é só rotina, né?”
Ao receber a notícia	“(silêncio) ... Câncer? Mas ele não tirou tudo? Eu achei que tinha acabado...”
Pergunta ativa	“Vou ter que operar de novo? Eu vou morrer?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Adiou a cirurgia por 10 anos por medo — revela com culpa se o candidato acolher
- Gostaria que a filha estivesse presente — só revela se perguntada se quer chamar alguém

COMPORTAMENTO DO ATOR

Inicialmente alegre e tranquila. Ao ouvir a notícia, fica em silêncio, depois chorosa e com culpa. Acalma-se se o candidato acolher, fizer pausas e explicar o plano.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-8 · Ambulatório — Retorno pós-operatório · nível difícil

Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias

Adenocarcinoma de vesícula biliar incidental (diagnosticado no anatomopatológico de colecistectomia), estádio pT2a (lado peritoneal) — indicação de estadiamento e re-ressecção radical.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Colangiocarcinoma peri-hilar (tumor de Klatskin) — icterícia obstrutiva indolor com dilatação de vias intra-hepáticas e vesícula NÃO distendida; diagnóstico por imagem (colangio-RM/TC).
- Colangiocarcinoma distal / tumor periampular — icterícia indolor com vesícula palpável (Courvoisier-Terrier).
- Câncer de vesícula avançado sintomático — dor, massa em HCD, icterícia, perda de peso: geralmente irressecável.
- Pólipo de vesícula ≥ 10 mm / vesícula em porcelana — lesões precursoras com indicação de colecistectomia profilática.

CONTEXTO CLÍNICO

O câncer de vesícula é a neoplasia mais comum das vias biliares; até metade dos casos é descoberta incidentalmente após colecistectomia (0,2–3% das peças). Tem alta incidência no Chile e em mulheres idosas com colelitíase de longa data.

JUSTIFICATIVA

Laudo com adenocarcinoma invadindo tecido perimuscular (pT2). Em tumores T1b ou mais, há indicação de reabordagem, pois há risco de doença residual no leito hepático e nos linfonodos; T1a com margens livres: colecistectomia simples é suficiente.

ANAMNESE ESPERADA

- Percepção da paciente sobre o exame
- Desejo de informação e de acompanhante
- Sintomas atuais (dor, icterícia, perda de peso)

EXAME FÍSICO ESPERADO

Exame abdominal, pesquisa de linfonodos (supraclavicular — Virchow; periumbilical — Irmã Maria José)

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC de tórax e abdome (ou RM de abdome) com contraste	Estadiamento: doença residual, metástases hepáticas, linfonodos, carcinomatose.	—
CA 19-9 e CEA	Marcadores basais para seguimento.	—
Revisão da lâmina por patologista (status de margem cística, T)	Define a extensão da re-ressecção.	—

CONDUTA ESPERADA

- Discussão em equipe multidisciplinar
- Re-ressecção radical em centro de referência em hepatobiliar (idealmente 4–8 semanas após a colecistectomia): ressecção hepática do leito vesicular (segmentos IVb/V) + linfadenectomia do ligamento hepatoduodenal ± ressecção da via biliar se margem cística comprometida; laparoscopia diagnóstica antes (risco de carcinomatose)
- Ressecção rotineira dos sítios de trocarte NÃO é recomendada
- Quimioterapia adjuvante (capecitabina — BILCAP) após ressecção
- Fatores de risco a citar: colelitíase de longa data e cálculos > 3 cm, vesícula em porcelana, pólipos ≥ 10 mm, anomalia da junção pancreatobiliar, colangite esclerosante primária, infecção crônica por

Salmonella, obesidade, sexo feminino, idade avançada

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- SPIKES: ambiente reservado, perguntar o que a paciente sabe, perguntar quanto quer saber e se deseja a presença da filha, comunicar com linguagem simples e sem jargões, pausas, acolher emoções e a culpa, apresentar o plano e manter esperança realista
- Não dizer que “não há mais nada a fazer”

ERROS CRÍTICOS

- Comunicar o diagnóstico de forma abrupta, sem acolhimento
- Indicar apenas acompanhamento clínico para tumor pT2
- Não solicitar estadiamento antes da re-ressecção
- Afirmar que a cirurgia já foi curativa

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-8 · Ambulatório — Retorno pós-operatório · nível difícil

Resultado da biópsia da vesícula retirada há 15 dias

CHECKLIST — CÂNCER DE VESÍCULA INCIDENTAL

COMUNICAÇÃO DE MÁS NOTÍCIAS	Pts	Avaliação
Perguntou o que a paciente sabe e quanto deseja saber; ofereceu presença de familiar Baile WF — Protocolo SPIKES, Oncologist 2000	1	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou o diagnóstico com linguagem clara, com aviso prévio e pausas SPIKES; INCA — Comunicação de Notícias Difíceis, 2010	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Acolheu as emoções (culpa, medo) e manteve esperança realista SPIKES	1	☐ A ☐ P ☐ I

INTERPRETAÇÃO E CONDUTA	Pts	Avaliação
Interpretou adenocarcinoma pT2 como indicação de re-ressecção (≥ T1b) NCCN Biliary Tract Cancers, 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou estadiamento (TC/RM tórax/abdome, CA 19-9) NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou ressecção hepática do leito (IVb/V) + linfadenectomia hilar, em centro de referência NCCN 2024; Sabiston 21ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou quimioterapia adjuvante (capecitabina) Primrose et al., BILCAP, Lancet Oncol 2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONHECIMENTO	Pts	Avaliação
Citou ≥ 3 fatores de risco (cálculo > 3 cm, porcelana, pólipo ≥ 10 mm, junção pancreatobiliar anômala, CEP) NCCN 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I
Diferenciou do colangiocarcinoma (icterícia obstrutiva indolor; Klatskin x distal/Courvoisier) Sabiston, 21ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-9 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias

CENÁRIO

Pronto-socorro, 16h.

PACIENTE

Gilberto, 62 anos, sexo masculino, comerciante.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor em fossa ilíaca esquerda há 3 dias, contínua, com febre e intestino preso.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Colete dados dirigidos e solicite o exame de imagem adequado.
2. Interprete a tomografia, formule o diagnóstico e classifique (Hinchey).
3. Proponha a conduta imediata e o seguimento.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-9 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	SpO2	Peso
136/84 mmHg	98 bpm	18 irpm	38,4 °C	97%	86 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, hidratado, corado, anictérico.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: discretamente distendido, ruídos hidroaéreos presentes, dor à palpação em fossa ilíaca esquerda com defesa e descompressão dolorosa LOCALIZADA; plastrão palpável em FIE; restante do abdome flácido e indolor
- TOQUE RETAL: sem massas, sem sangue

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Leucócitos	**17.200/mm³ (8% bastões)**	4.000–11.000/mm³
PCR	**186 mg/L**	< 5 mg/L
Creatinina	1,0 mg/dL	0,7–1,3 mg/dL
Urina tipo I	Normal	—

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC DE ABDOME E PELVE COM CONTRASTE (entregar se solicitada): múltiplos divertículos em cólon sigmoide; espessamento parietal do sigmoide com densificação da gordura pericólica; COLEÇÃO PERICÓLICA de 5,0 x 4,2 cm, com nível hidroaéreo, adjacente ao sigmoide; sem pneumoperitônio difuso; sem líquido livre em cavidade.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-9 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico, laboratório e TC SOMENTE se solicitados. Se o candidato pedir colonoscopia agora, informar “está contraindicada na fase aguda” e ANOTAR. Se indicar cirurgia de urgência (Hartmann), questionar: “o paciente está estável — há outra opção?”.

PERFIL DO PACIENTE

Gilberto, 62 anos, comerciante, obeso, sedentário, dieta pobre em fibras. Teve 1 episódio de “inflamação no intestino” há 2 anos, tratado com antibiótico oral em casa. Nunca fez colonoscopia.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Doutor, tô com uma dor aqui embaixo do lado esquerdo faz três dias, só piora. E tô com febre.”
Hábito intestinal	“O intestino travou um pouco, tô evacuando pouco. Sem sangue.”
Episódio prévio	“Há uns dois anos tive uma coisa parecida, mais fraca. Tomei antibiótico em casa e passou.”
Sintomas urinários	“Xixi normal, sem ardência, sem ar na urina.”
Pergunta ativa	“Vou ter que operar e ficar com bolsinha?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Episódio prévio de diverticulite há 2 anos — só revela se perguntado sobre crises anteriores
- Nunca fez colonoscopia — revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Com dor moderada, colaborativo, muito preocupado com a possibilidade de colostomia.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-9 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias

Diverticulite aguda complicada do cólon sigmoide com abscesso pericólico de 5 cm — Hinchey Ib (Hinchey modificada) / WSES 1b–2a, em paciente estável.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Câncer de cólon perfurado/bloqueado — pode simular diverticulite: colonoscopia obrigatória após a fase aguda.
- Colite isquêmica — dor e sangramento, idosos com fatores de risco cardiovascular.
- Doença inflamatória intestinal — evolução mais crônica, diarreia.
- Afecções urológicas (litíase, ITU) / ginecológicas em mulheres — afastadas pela clínica e pela TC.

CONTEXTO CLÍNICO

A diverticulite acomete principalmente o sigmoide em países ocidentais. Cerca de 15–20% dos casos são complicados (abscesso, perfuração, fístula, obstrução). Abscessos > 3–4 cm devem ser drenados por via percutânea quando acessíveis.

JUSTIFICATIVA

Dor em FIE, febre, leucocitose e PCR elevada; TC com divertículos, inflamação pericólica e abscesso pericólico de 5 cm sem peritonite difusa = Hinchey Ib (abscesso pericólico).

ANAMNESE ESPERADA

- Localização e evolução da dor
- Febre
- Alteração do hábito intestinal, sangramento
- Sintomas urinários (pneumatúria/fecalúria — fístula)
- Episódios prévios
- Colonoscopia prévia
- Imunossupressão

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação abdominal com pesquisa de irritação peritoneal localizada vs difusa
- Massa/plastrão
- Toque retal

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC de abdome e pelve com contraste	Padrão-ouro para diagnóstico e classificação.	Abscesso pericólico de 5 cm.
Hemograma, PCR, função renal, urina I	Gravidade e diferenciais.	Leucocitose, PCR elevada.
Colonoscopia 6–8 semanas após a resolução	Excluir neoplasia, sobretudo após diverticulite complicada.	—

CONDUTA ESPERADA

- Internação, analgesia, hidratação, dieta zero/líquida conforme tolerância
- Antibiótico EV com cobertura para Gram-negativos e anaeróbios (ex.: ceftriaxona + metronidazol, ou amoxicilina-clavulanato, ou piperacilina-tazobactam)
- Abscesso ≥ 3–4 cm: DRENAGEM PERCUTÂNEA guiada por TC/US
- Cirurgia de urgência se falha do tratamento, peritonite difusa (Hinchey III/IV) ou instabilidade
- Após resolução: colonoscopia em 6–8 semanas; discutir sigmoidectomia eletiva (diverticulite complicada com abscesso e episódio recorrente)

- Orientações: dieta rica em fibras, atividade física, perda de peso, cessar tabagismo

COMUNICAÇÃO ESPERADA

Explicar o diagnóstico, que neste momento não há necessidade de colostomia, e a necessidade de colonoscopia futura

ERROS CRÍTICOS

- Solicitar colonoscopia na fase aguda
- Tratar ambulatorialmente com antibiótico oral um paciente com abscesso de 5 cm
- Indicar cirurgia de urgência (Hartmann) em paciente estável com abscesso drenável
- Não programar colonoscopia após a resolução

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-9 · PS — Pronto-Socorro · nível moderado

Dor no lado esquerdo baixo da barriga com febre há 3 dias

CHECKLIST — DIVERTICULITE AGUDA COMPLICADA

AVALIAÇÃO	Pts	Avaliação
Caracterizou a dor, febre, hábito intestinal, sintomas urinários e episódios prévios ASCRS Clinical Practice Guidelines — Diverticulitis, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou irritação peritoneal localizada x difusa WSES Guidelines on Acute Left Colonic Diverticulitis, 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou TC de abdome e pelve com contraste ASCRS 2020; WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Diagnosticou diverticulite complicada com abscesso pericólico — Hinchey Ib Classificação de Hinchey modificada (Wasvary)	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Internação e antibiótico EV com cobertura para Gram-negativos e anaeróbios WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou drenagem percutânea do abscesso (> 3–4 cm) WSES 2020; ASCRS 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou indicações de cirurgia de urgência (peritonite difusa, falha, instabilidade) WSES 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Programou colonoscopia em 6–8 semanas e discutiu sigmoidectomia eletiva ASCRS 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-10 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito

CENÁRIO

Pronto-socorro, 22h.

PACIENTE

Felipe, 19 anos, sexo masculino, estudante.

QUEIXA PRINCIPAL

Dor abdominal há 18 horas, que começou ao redor do umbigo e passou para o lado direito, com enjoo e falta de apetite.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize o exame físico abdominal dirigido, verbalizando os sinais pesquisados (achados mediante solicitação).
2. Calcule o escore de Alvarado e formule o diagnóstico.
3. Defina a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-10 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso
120/74 mmHg	96 bpm	18 irpm	37,9 °C	70 kg

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, hidratado, fácies de dor, caminha encurvado.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: plano, ruídos hidroaéreos presentes, dor à palpação em fossa ilíaca direita, máxima no ponto de McBurney; SINAL DE BLUMBERG POSITIVO; SINAL DE ROVSING POSITIVO (dor em FID à compressão da FIE); sinal do psoas positivo; sinal do obturador negativo; sem massas
- GIORDANO: negativo
- GENITAIS: testículos sem alterações

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Leucócitos	**15.800/mm³ (neutrófilos 85%, 6% bastões)**	4.000–11.000/mm³
PCR	**48 mg/L**	< 5 mg/L
Urina tipo I	Normal	—

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

ULTRASSONOGRAFIA (entregar somente se solicitada): apêndice cecal não compressível, com diâmetro de 9 mm, densificação da gordura periapendicular; sem coleções.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-10 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico SOMENTE se o candidato verbalizar as manobras (McBurney, Blumberg, Rovsing, psoas/obturador). Exames laboratoriais se solicitados. O exame de imagem não é obrigatório neste caso (Alvarado alto em homem jovem) — não penalizar se solicitado.

PERFIL DO PACIENTE

Felipe, 19 anos, estudante universitário, saudável, sem cirurgias prévias.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Começou ontem à noite uma dor em volta do umbigo, meio difusa. Hoje a dor foi pro lado direito, embaixo, e tá mais forte.”
Apetite / náusea	“Não tenho fome nenhuma, e tô enjoado. Vomitei uma vez.”
Febre	“Tô me sentindo quente, meio febril.”
Hábito intestinal / urinário	“Intestino normal, urina normal.”
Pergunta ativa	“Não dá pra tomar um remédio e ir embora? Amanhã tenho prova.”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Tem prova amanhã e quer ir embora — revela na pergunta ativa
- Piora da dor ao caminhar e com solavancos do carro — só revela se perguntado sobre fatores de piora

COMPORTAMENTO DO ATOR

Com dor, mas tenta minimizar porque quer ir embora para a prova. Aceita a cirurgia se bem explicada.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-10 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito

Apendicite aguda (não complicada, provável fase flegmonosa), Alvarado 10.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Linfadenite mesentérica — jovens, após quadro viral; sem irritação peritoneal franca.
- Gastroenterite — diarreia e vômitos precedem a dor; dor difusa.
- Litíase ureteral direita / pielonefrite — dor lombar em cólica, Giordano positivo, hematúria/piúria (urina normal).
- Torção testicular / doença de Crohn ileal — afastadas pelo exame e história.

CONTEXTO CLÍNICO

Apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo cirúrgico, com pico entre 10 e 30 anos. A migração da dor periumbilical para FID (dor visceral → somática) é o achado clínico mais característico.

JUSTIFICATIVA

Escore de Alvarado (MANTRELS): Migração da dor (1) + Anorexia (1) + Náusea/vômito (1) + Tenderness/dor em FID (2) + Rebound/descompressão dolorosa (1) + Elevação de temperatura ≥ 37,3 °C (1) + Leucocitose > 10.000 (2) + Shift/desvio à esquerda (1) = 10. Escore ≥ 7 = alta probabilidade → cirurgia.

ANAMNESE ESPERADA

- Cronologia e migração da dor
- Anorexia, náuseas, vômitos
- Febre
- Sintomas urinários e intestinais

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Ponto de McBurney
- Blumberg
- Rovsing
- Psoas e obturador
- Giordano
- Exame testicular

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Hemograma e PCR	Compõem o escore e auxiliam no diagnóstico.	Leucocitose com desvio.
Urina tipo I	Afastar ITU/litíase.	Normal.
USG ou TC	Úteis em dúvida diagnóstica, mulheres, idosos e obesos; dispensáveis com Alvarado alto em homem jovem.	Apêndice > 6 mm não compressível.

CONDUTA ESPERADA

- Jejum, hidratação venosa, analgesia (não mascara o diagnóstico), antiemético
- Antibioticoprofilaxia pré-operatória (ex.: cefazolina + metronidazol ou cefoxitina, dose única em apendicite não complicada; manter antibiótico no pós-operatório apenas se complicada/perfurada)
- APENDICECTOMIA, preferencialmente videolaparoscópica
- Tratamento não operatório com antibiótico é opção apenas em casos selecionados (não complicados, com TC), com risco de recorrência de ~30–40% em 5 anos
- Orientar o paciente sobre a necessidade da cirurgia (a prova pode ser remarcada)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar o diagnóstico e os riscos de adiar (perfuração, peritonite)

- Oferecer atestado / declaração para a faculdade

ERROS CRÍTICOS

- Liberar o paciente com analgésico/antiespasmódico
- Não pesquisar sinais de irritação peritoneal
- Não indicar apendicectomia com Alvarado ≥ 7
- Atrasar a cirurgia aguardando exame de imagem desnecessário

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-10 · PS — Pronto-Socorro · nível fácil

Dor que começou no umbigo e foi para o lado direito

CHECKLIST — APENDICITE AGUDA

EXAME FÍSICO	Pts	Avaliação
Pesquisou dor no ponto de McBurney e sinal de Blumberg WSES Jerusalem Guidelines — Acute Appendicitis, 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou Rovsing, psoas e/ou obturador Sabiston, 21ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou Giordano e/ou examinou genitais (diferenciais) Sabiston, 21ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Calculou o escore de Alvarado corretamente (10) Alvarado A, Ann Emerg Med 1986	2	☐ A ☐ P ☐ I
Diagnosticou apendicite aguda WSES 2020	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Jejum, hidratação e analgesia WSES 2020	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Antibioticoprofilaxia pré-operatória WSES 2020	1	☐ A ☐ P ☐ I
Indicou apendicectomia (preferencialmente laparoscópica) WSES 2020	2	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-11 · Ambulatório — Cirurgia Bariátrica e Metabólica · nível moderado

Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago

CENÁRIO

Ambulatório de cirurgia bariátrica de hospital público. Primeira consulta.

PACIENTE

Patrícia, 38 anos, sexo feminino, auxiliar administrativa.

QUEIXA PRINCIPAL

Deseja fazer cirurgia bariátrica. Tem obesidade desde a adolescência e diabetes há 4 anos.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Verifique se a paciente tem indicação de cirurgia bariátrica, coletando os dados necessários.
2. Cite a avaliação pré-operatória necessária e as contraindicações a pesquisar.
3. Indique a técnica mais adequada e oriente os cuidados pós-operatórios de longo prazo.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-11 · Ambulatório — Cirurgia Bariátrica e Metabólica · nível moderado

Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Peso	Altura	IMC	Circ. abdominal
146/92 mmHg	84 bpm	16 irpm	112 kg	1,64 m	41,6 kg/m²	124 cm

EXAME FÍSICO GERAL

Bom estado geral, obesidade grau III, acantose nigricans em região cervical e axilas.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- APARELHO RESPIRATÓRIO E CARDIOVASCULAR: sem alterações
- ABDOME: globoso, sem hérnias, indolor
- MEMBROS: edema 1+/4+ em tornozelos

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
HbA1c	**8,6%**	< 5,7%
Glicemia de jejum	**178 mg/dL**	< 100 mg/dL
Triglicerídeos / HDL	**260 / 34 mg/dL**	< 150 / > 50
TSH	2,1 mUI/L	0,4–4,0

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-11 · Ambulatório — Cirurgia Bariátrica e Metabólica · nível moderado

Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais (com IMC) e exames no início. Responder às perguntas conforme o roteiro. A paciente NÃO tem contraindicações: sem uso de álcool/drogas, sem transtorno psiquiátrico descompensado, entende o tratamento.

PERFIL DO PACIENTE

Patrícia, 38 anos, auxiliar administrativa, casada, 1 filho de 10 anos. Tentou diversas dietas, academia, sibutramina, e usa liraglutida há 1 ano sem sucesso sustentado. Hipertensa (losartana 50 mg), diabética (metformina 850 mg 2x/dia + glicazida), ronca muito e acorda cansada. Tem azia frequente. Não fuma, não bebe. Gostaria de ter outro filho.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa / motivação	“Doutor, eu quero fazer a cirurgia. Já tentei de tudo, emagreço e engordo de novo. E agora o diabetes não tá controlando.”
Tratamentos prévios	“Já fiz dieta com nutricionista, academia, tomei sibutramina e agora tô na liraglutida há um ano. Perco uns quilos e volto a ganhar.”
Comorbidades	“Tenho pressão alta e diabetes. Meu marido diz que eu ronco muito e paro de respirar dormindo.”
Refluxo	“Tenho muita azia, quase todo dia.”
Álcool / drogas / saúde mental	“Não bebo, não fumo. Já tive ansiedade, mas tô bem, faço terapia.”
Pergunta ativa	“Qual cirurgia é melhor pra mim? E posso engravidar depois?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Desejo de nova gestação — só revela se perguntada sobre planos reprodutivos ou na pergunta ativa
- Roncos e apneias observadas pelo marido — só revela se perguntada sobre sono
- Azia diária — só revela se perguntada sobre sintomas digestivos

COMPORTAMENTO DO ATOR

Motivada, um pouco ansiosa, bem informada pela internet. Quer saber “qual a melhor cirurgia”.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-11 · Ambulatório — Cirurgia Bariátrica e Metabólica · nível moderado

Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago

Obesidade grau III (IMC 41,6 kg/m²) com diabetes tipo 2 descontrolado, hipertensão, provável apneia obstrutiva do sono e DRGE, com falha do tratamento clínico — com indicação de cirurgia bariátrica/metabólica; técnica preferencial: bypass gástrico em Y de Roux.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Obesidade secundária a hipotireoidismo — afastada (TSH normal).
- Síndrome de Cushing — considerar se estrias violáceas, fraqueza proximal, HAS refratária; rastrear se suspeita.
- Obesidade associada a medicamentos (antipsicóticos, corticoides) — não presente.

CONTEXTO CLÍNICO

A cirurgia bariátrica é o tratamento mais eficaz e duradouro para obesidade grave, com remissão do DM2 em grande parte dos pacientes e redução de mortalidade cardiovascular. A indicação exige avaliação multidisciplinar.

JUSTIFICATIVA

Critérios clássicos (CFM/SBCBM): IMC ≥ 40 kg/m² independentemente de comorbidades, ou IMC ≥ 35 com comorbidades graves; falha de tratamento clínico; idade entre 18 e 65 anos (exceções avaliadas); ausência de contraindicações. Diretrizes internacionais (ASMBS/IFSO 2022) ampliam para IMC ≥ 35 independentemente de comorbidades e consideram IMC 30–34,9 com doença metabólica. A paciente preenche critérios com folga (IMC 41,6 + DM2, HAS, SAOS).

ANAMNESE ESPERADA

- Histórico de peso e tratamentos prévios
- Comorbidades (DM2, HAS, SAOS, DRGE, dislipidemia, osteoartrose)
- Uso de álcool e drogas
- Transtornos psiquiátricos e alimentares (compulsão)
- Planos reprodutivos
- Tabagismo

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Peso, altura, IMC, circunferência abdominal
- Sinais de hipercortisolismo
- Acantose

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Avaliação multidisciplinar: endocrinologia, nutrição, psicologia/psiquiatria	Exigida para indicação e preparo.	—
Endoscopia digestiva alta com pesquisa de H. pylori	Avaliar esofagite, hérnia hiatal, Barrett e lesões gástricas (o estômago excluído no bypass não poderá ser avaliado depois).	—
USG de abdome	Colelitíase e esteatose hepática.	—
Polissonografia, avaliação cardiológica (ECG, ecocardiograma conforme risco), espirometria se indicado	Risco cirúrgico e SAOS (CPAP pré-operatório).	—

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Laboratório: hemograma, ferro/ferritina, B12, ácido fólico, vitamina D, cálcio, PTH, função renal e hepática, perfil lipídico, beta-hCG	Corrigir deficiências antes da cirurgia.	—

CONDUTA ESPERADA

- Técnica: BYPASS GÁSTRICO EM Y DE ROUX laparoscópico — preferido por DM2 descontrolado e DRGE (a gastrectomia vertical/sleeve pode piorar o refluxo)
- Contraindicações a pesquisar: dependência ativa de álcool/drogas, transtorno psiquiátrico grave descompensado, incapacidade de compreender o tratamento e aderir ao seguimento, risco cirúrgico proibitivo, doença endócrina causal não tratada
- Pós-operatório de longo prazo: suplementação por toda a vida — polivitamínico, vitamina B12, ferro, cálcio (citrato) + vitamina D; dieta em fases (líquida → pastosa → sólida), proteína adequada, comer devagar, evitar doces (síndrome de dumping)
- Seguimento multidisciplinar e exames periódicos
- Gestação: evitar por 12–18 meses após a cirurgia (contracepção não oral eficaz, pois a absorção de anticoncepcional oral pode ser reduzida); após esse período, gestação é segura com acompanhamento
- Atividade física regular

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Explicar benefícios e riscos, sem prometer resultados mágicos
- Responder sobre gestação
- Reforçar a necessidade de acompanhamento por toda a vida

ERROS CRÍTICOS

- Indicar a cirurgia sem avaliação multidisciplinar (incluindo psicológica/psiquiátrica)
- Não pesquisar uso de álcool/drogas e transtornos psiquiátricos
- Não orientar suplementação vitamínica permanente
- Não orientar adiamento da gestação por 12–18 meses
- Indicar sleeve sem considerar a DRGE sintomática

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-11 · Ambulatório — Cirurgia Bariátrica e Metabólica · nível moderado

Mulher com obesidade e diabetes que quer operar o estômago

CHECKLIST — CIRURGIA BARIÁTRICA

INDICAÇÃO	Pts	Avaliação
Calculou/considerou o IMC e citou critérios de indicação (IMC ≥ 40 ou ≥ 35 + comorbidades; falha clínica) CFM Res. 2.131/2015; ASMBS/IFSO 2022	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou comorbidades (DM2, HAS, SAOS, DRGE) e tratamentos prévios SBCBM	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou contraindicações (álcool/drogas, transtorno psiquiátrico descompensado) CFM Res. 2.131/2015	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

PRÉ-OPERATÓRIO	Pts	Avaliação
Citou avaliação multidisciplinar (endocrino, nutrição, psicologia/psiquiatria) CFM Res. 2.131/2015	1	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou EDA (com H. pylori), USG abdome e avaliação cardiopulmonar/polissonografia ASMBS Perioperative Guidelines, 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I

TÉCNICA E PÓS-OPERATÓRIO	Pts	Avaliação
Indicou bypass gástrico em Y de Roux, justificando pelo DM2 e pela DRGE ASMBS/IFSO 2022; SBCBM	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou suplementação vitamínica permanente (polivitamínico, B12, ferro, cálcio + vitamina D) ASMBS Micronutrient Guidelines, 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou evitar gestação por 12–18 meses e contracepção adequada ACOG; ASMBS 2019	1	☐ A ☐ P ☐ I
Comunicou riscos/benefícios e necessidade de seguimento por toda a vida CFM — Código de Ética Médica, 2019	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-12 · Ambulatório — Coloproctologia · nível moderado

Anemia e cansaço em homem de 61 anos

CENÁRIO

Ambulatório de coloproctologia. Paciente encaminhado pela UBS com resultado de colonoscopia.

PACIENTE

Osvaldo, 61 anos, sexo masculino, contador.

QUEIXA PRINCIPAL

Cansaço progressivo há 4 meses; o clínico encontrou anemia e solicitou colonoscopia.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Interprete a colonoscopia e o anatomopatológico.
2. Solicite os exames de estadiamento.
3. Proponha o tratamento cirúrgico e o seguimento, comunicando o diagnóstico ao paciente.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-12 · Ambulatório — Coloproctologia · nível moderado

Anemia e cansaço em homem de 61 anos

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso
124/76 mmHg	92 bpm	16 irpm	36,4 °C	71 kg (há 6 meses: 76 kg)

EXAME FÍSICO GERAL

Hipocorado 2+/4+, hidratado, bom estado geral.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: flácido, massa endurecida e pouco móvel de cerca de 5 cm em flanco/fossa ilíaca direita, indolor; fígado não palpável
- TOQUE RETAL: sem massas, fezes escuras normais
- LINFONODOS: sem linfonodomegalias

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Hemoglobina / VCM	**8,9 g/dL / 71 fL**	13–17 g/dL / 80–100 fL
Ferritina	**9 ng/mL**	30–400 ng/mL
Pesquisa de sangue oculto nas fezes	**Positiva**	Negativa

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

COLONOSCOPIA (entregar no início): lesão vegetante, ulcerada, friável, ocupando 3/4 da circunferência do cólon ascendente, a 5 cm da válvula ileocecal, transponível; restante do cólon até o ceco sem outras lesões; preparo adequado. ANATOMOPATOLÓGICO: ADENOCARCINOMA moderadamente diferenciado.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-12 · Ambulatório — Coloproctologia · nível moderado

Anemia e cansaço em homem de 61 anos

NOTA AO AVALIADOR

Entregar colonoscopia e anatomopatológico no início. Se o candidato solicitar TC de tórax, abdome e pelve e CEA, informar: “TC sem metástases a distância; espessamento parietal do cólon ascendente com linfonodos pericólicos de até 1,2 cm; CEA 8,4 ng/mL (VR < 5)”.

PERFIL DO PACIENTE

Osvaldo, 61 anos, contador, casado, 2 filhos (35 e 32 anos). Sedentário, come muita carne vermelha e embutidos, ex-tabagista. Nunca fez rastreamento. Irmão teve “pólipos” no intestino.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Abertura	“Doutor, o médico do posto disse que eu tô com anemia e pediu esse exame. Deu alguma coisa?”
Sintomas	“Tô muito cansado, sem ar pra subir escada. Emagreci uns cinco quilos.”
Hábito intestinal	“O intestino tá normal. Nunca vi sangue.”
Família	“Meu irmão tirou uns pólipos do intestino ano passado.”
Pergunta ativa	“É câncer? Tem cura? Meus filhos também correm risco?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Irmão com pólipos colônicos — só revela se perguntado sobre história familiar
- Nunca fez colonoscopia ou pesquisa de sangue oculto de rastreamento — revela se perguntado

COMPORTAMENTO DO ATOR

Apreensivo, quer respostas diretas. Fica preocupado com os filhos.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-12 · Ambulatório — Coloproctologia · nível moderado

Anemia e cansaço em homem de 61 anos

Adenocarcinoma de cólon ascendente, com anemia ferropriva e perda de peso, estadiamento clínico cT3 N+ M0 (estádio III provável) — indicação de colectomia direita oncológica.

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Outras causas de anemia ferropriva no homem (úlcera péptica, angiodisplasia, doença celíaca) — o tumor explica o quadro; a EDA pode ser feita se não houver lesão colônica.
- Linfoma de cólon / tumor carcinoide — definidos pelo anatomopatológico.
- Abscesso/plastrão apendicular ou doença de Crohn ileocecal — afastados pela colonoscopia e biópsia.

CONTEXTO CLÍNICO

O câncer colorretal é o 2º–3º mais incidente no Brasil. Tumores de cólon direito costumam manifestar-se por anemia ferropriva oculta, massa palpável e perda de peso; os de cólon esquerdo, por alteração do hábito intestinal e obstrução.

JUSTIFICATIVA

Anemia ferropriva com sangue oculto positivo em homem de 61 anos + colonoscopia com lesão vegetante em cólon ascendente + biópsia de adenocarcinoma.

ANAMNESE ESPERADA

- Sintomas (anemia, perda de peso, alteração do hábito, sangramento, dor)
- História familiar de CCR/pólipos
- Rastreamento prévio
- Comorbidades

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Palpação abdominal (massa, hepatomegalia)
- Toque retal
- Linfonodos

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC de tórax, abdome e pelve com contraste	Estadiamento a distância (fígado e pulmão são os principais sítios).	Sem metástases; linfonodos pericólicos suspeitos.
CEA (antígeno carcinoembrionário)	Prognóstico e seguimento pós-operatório.	8,4 ng/mL.
Colonoscopia completa	Excluir lesões sincrônicas (3–5%).	Já realizada — sem outras lesões.
Hemograma, função renal, avaliação de risco cirúrgico	Preparo.	—

CONDUTA ESPERADA

- Colectomia direita (hemicolectomia direita) oncológica, preferencialmente videolaparoscópica, com ligadura vascular na origem e linfadenectomia (≥ 12 linfonodos), anastomose ileotransversa
- Correção da anemia: ferro endovenoso no pré-operatório (programa de patient blood management)
- Quimioterapia adjuvante se estádio III (pN+): FOLFOX ou CAPOX (3–6 meses)
- Seguimento: CEA a cada 3–6 meses, TC anual por 3–5 anos, colonoscopia em 1 ano
- Familiares de 1º grau: colonoscopia a partir dos 40 anos ou 10 anos antes da idade do diagnóstico do familiar

- Pesquisar instabilidade de microssatélites (MMR/MSI) no tumor (síndrome de Lynch)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar o diagnóstico com empatia (SPIKES)
- Explicar que há tratamento com intenção curativa
- Orientar rastreamento dos filhos

ERROS CRÍTICOS

- Tratar apenas a anemia com ferro sem abordar o tumor
- Indicar cirurgia sem estadiamento (TC de tórax/abdome/pelve e CEA)
- Indicar ressecção local/endoscópica para adenocarcinoma invasivo volumoso
- Não orientar rastreamento dos familiares de 1º grau

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-12 · Ambulatório — Coloproctologia · nível moderado

Anemia e cansaço em homem de 61 anos

CHECKLIST — CÂNCER DE CÓLON DIREITO

DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO	Pts	Avaliação
Interpretou colonoscopia e biópsia como adenocarcinoma de cólon ascendente NCCN Colon Cancer, 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Correlacionou com anemia ferropriva/sangue oculto (apresentação típica do cólon direito) Sabiston, 21ª ed.	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou TC de tórax, abdome e pelve NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou CEA NCCN 2024	1	☐ A ☐ P ☐ I

TRATAMENTO	Pts	Avaliação
Indicou colectomia direita oncológica com linfadenectomia (≥ 12 linfonodos) NCCN 2024; ASCRS Colon Cancer Guidelines, 2022	2	☐ A ☐ P ☐ I
Citou quimioterapia adjuvante no estádio III (FOLFOX/CAPOX) NCCN 2024; IDEA collaboration, NEJM 2018	1	☐ A ☐ P ☐ I
Citou correção da anemia (ferro EV) no pré-operatório NATA/ERAS Guidelines	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

COMUNICAÇÃO E SEGUIMENTO	Pts	Avaliação
Comunicou o diagnóstico com empatia e explicou a intenção curativa Protocolo SPIKES	1	☐ A ☐ P ☐ I
Orientou colonoscopia dos familiares de 1º grau (a partir dos 40 anos) US Multi-Society Task Force, 2017	1	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado

IMPRESSO DO CANDIDATO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-13 · Enfermaria — Cirurgia Geral · nível difícil

Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu

CENÁRIO

Enfermaria de cirurgia geral. Paciente internado para investigação.

PACIENTE

Seu Joaquim, 67 anos, sexo masculino, aposentado.

QUEIXA PRINCIPAL

Olhos e pele amarelados há 3 semanas, coceira no corpo, urina escura, fezes claras e emagrecimento de 8 kg em 2 meses.

TAREFAS (TEMPO: 5 MINUTOS)

1. Realize anamnese e exame físico dirigidos (achados mediante solicitação), identificando o sinal semiológico relevante.
2. Formule a hipótese diagnóstica e solicite o exame de imagem adequado.
3. Interprete o laudo, avalie a ressecabilidade e defina a conduta.

IMPRESSOS PARA O CANDIDATO (entregar conforme solicitação)

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-13 · Enfermaria — Cirurgia Geral · nível difícil

Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu

SINAIS VITAIS

PA	FC	FR	Tax	Peso
128/78 mmHg	78 bpm	16 irpm	36,5 °C	64 kg (há 2 meses: 72 kg)

EXAME FÍSICO GERAL

Ictérico 3+/4+, emagrecido, escoriações de coçadura em tronco e membros, afebril.

EXAME FÍSICO SEGMENTAR

- ABDOME: flácido, indolor; VESÍCULA BILIAR PALPÁVEL, distendida e INDOLOR em hipocôndrio direito (sinal de Courvoisier-Terrier); fígado palpável a 2 cm do rebordo costal; sem ascite
- LINFONODOS: sem linfonodo supraclavicular esquerdo palpável; sem nódulo periumbilical

EXAMES (ENTREGAR SOMENTE SE SOLICITADOS)

Exame	Resultado	Referência
Bilirrubina total / direta	**14,2 / 12,1 mg/dL**	< 1,2 / < 0,3 mg/dL
Fosfatase alcalina / GGT	**780 / 920 U/L**	< 120 / < 50 U/L
AST / ALT	**88 / 102 U/L**	< 40 U/L
CA 19-9	**410 U/mL**	< 37 U/mL
Glicemia de jejum	**168 mg/dL (diabetes de início recente)**	< 100 mg/dL
INR / albumina	**1,4 / 3,2 g/dL**	< 1,2 / 3,5–5,0

IMAGEM / LAUDO (SE SOLICITADO)

TC DE ABDOME COM PROTOCOLO PARA PÂNCREAS — trifásica (entregar se solicitada): massa hipodensa de 2,8 cm em cabeça do pâncreas, com dilatação das vias biliares intra e extra-hepáticas e do ducto pancreático principal (sinal do “duplo ducto”); vesícula distendida; contato da massa com a veia mesentérica superior < 180°, sem deformidade ou trombose venosa; artéria mesentérica superior, tronco celíaco e artéria hepática comum livres (plano de gordura preservado); sem metástases hepáticas, sem ascite. TC de tórax: sem nódulos.

INSTRUÇÕES AO AVALIADOR / PACIENTE SIMULADO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-13 · Enfermaria — Cirurgia Geral · nível difícil

Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu

NOTA AO AVALIADOR

Entregar sinais vitais no início. Exame físico e exames SOMENTE se solicitados. O candidato deve identificar o sinal de Courvoisier-Terrier. Se o candidato indicar drenagem biliar pré-operatória de rotina (CPRE com prótese) sem justificativa, ANOTAR; aceitar se justificar por colangite, prurido intratável, atraso previsto da cirurgia ou neoadjuvância.

PERFIL DO PACIENTE

Joaquim, 67 anos, aposentado (ex-metalúrgico), tabagista 40 maços-ano. Diagnosticado com diabetes há 3 meses. Sem etilismo. Mora com a esposa.

ROTEIRO DE FALAS

Se perguntado sobre…	Fala
Queixa principal	“Fiquei amarelo de uns tempos pra cá, e coça o corpo inteiro, doutor, não consigo dormir.”
Dor	“Dor não tenho. Às vezes um incômodo nas costas.”
Urina e fezes	“A urina tá escura como Coca-Cola, e o cocô ficou branquinho.”
Perda de peso	“Perdi uns oito quilos em dois meses, sem fazer dieta.”
Febre / calafrios	“Febre não tive.”
Pergunta ativa	“Doutor, é hepatite? É coisa ruim?”

INFORMAÇÕES OCULTAS (SÓ REVELAR SE PERGUNTADO)

- Diabetes diagnosticado há 3 meses (diabetes de início recente após 50 anos) — só revela se perguntado sobre doenças recentes
- Tabagismo de longa data — revela se perguntado
- Incômodo lombar — só revela se perguntado sobre dor nas costas

COMPORTAMENTO DO ATOR

Preocupado, coçando-se constantemente, desconfiado de que é algo grave.

GABARITO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-13 · Enfermaria — Cirurgia Geral · nível difícil

Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu

Icterícia obstrutiva indolor por adenocarcinoma de cabeça de pâncreas (sinal de Courvoisier-Terrier), RESSECÁVEL pelos critérios do NCCN (contato venoso ≤ 180° sem irregularidade, sem contato arterial, sem metástases).

DIAGNÓSTICOS DIFERENCIAIS

- Coledocolitíase — icterícia flutuante com dor tipo cólica; vesícula geralmente não palpável (fibrose por colecistite crônica).
- Colangiocarcinoma distal / ampuloma — também causam Courvoisier; ampuloma pode ter icterícia flutuante e melena; diferenciados por TC/ecoendoscopia.
- Pancreatite crônica com estenose biliar — dor crônica, etilismo, calcificações.
- Hepatite — icterícia com padrão hepatocelular (transaminases muito elevadas), sem dilatação das vias biliares.

CONTEXTO CLÍNICO

O adenocarcinoma ductal de pâncreas é altamente letal; apenas 15–20% dos pacientes são ressecáveis ao diagnóstico. Tumores de cabeça manifestam-se por icterícia obstrutiva indolor, perda de peso e, às vezes, diabetes de início recente. Tabagismo é o principal fator de risco modificável.

JUSTIFICATIVA

Icterícia colestática progressiva indolor + prurido + colúria + acolia + perda de peso + vesícula palpável indolor (lei de Courvoisier-Terrier) + diabetes recente + CA 19-9 elevado + TC com massa de cabeça de pâncreas e duplo ducto.

ANAMNESE ESPERADA

- Evolução da icterícia (progressiva vs flutuante), dor, prurido, colúria e acolia
- Perda de peso
- Diabetes recente
- Febre (colangite)
- Tabagismo, etilismo, história familiar

EXAME FÍSICO ESPERADO

- Icterícia
- Vesícula palpável indolor (Courvoisier-Terrier)
- Hepatomegalia, ascite
- Linfonodos de Virchow e Irmã Maria José

EXAMES ESPERADOS

Exame	Justificativa	Resultado esperado
TC de abdome com protocolo para pâncreas (trifásica)	Exame de escolha para diagnóstico e avaliação de ressecabilidade (relação com vasos).	Massa de cabeça, ressecável.
TC de tórax	Estadiamento a distância.	Sem metástases.
CA 19-9 (após descompressão biliar, idealmente)	Prognóstico e seguimento (pode estar falsamente elevado na colestase).	Elevado.

Exame	Justificativa	Resultado esperado
Ecoendoscopia com punção	Confirmação histológica quando necessária (obrigatória antes de neoadjuvância); não é obrigatória antes da ressecção de tumor ressecável com alta suspeita.	—

CONDUTA ESPERADA

- Discussão em equipe multidisciplinar em centro de alto volume
- Tumor ressecável: DUODENOPANCREATECTOMIA (cirurgia de Whipple) seguida de quimioterapia adjuvante (mFOLFIRINOX em pacientes com bom desempenho; alternativa gencitabina + capecitabina); neoadjuvância pode ser considerada em casos selecionados (CA 19-9 muito elevado, alto risco)
- Drenagem biliar pré-operatória NÃO rotineira (aumenta complicações — estudo DROP-trial); indicada se colangite, prurido intratável, insuficiência renal, cirurgia postergada ou neoadjuvância — preferir prótese metálica por CPRE
- Suporte: correção da coagulação (vitamina K), nutrição, controle do prurido (colestiramina), controle glicêmico
- Se irressecável/metastático: paliação (prótese biliar, quimioterapia, cuidados paliativos, analgesia — inclusive neurólise do plexo celíaco)

COMUNICAÇÃO ESPERADA

- Comunicar a suspeita de tumor com empatia, explicando que há possibilidade de cirurgia com intenção curativa
- Envolver a família

ERROS CRÍTICOS

- Não identificar o sinal de Courvoisier-Terrier / atribuir a icterícia a hepatite
- Não solicitar TC com protocolo de pâncreas para avaliar ressecabilidade
- Indicar drenagem biliar pré-operatória de rotina sem indicação
- Indicar apenas tratamento paliativo para tumor ressecável sem discussão multidisciplinar

CHECKLIST DE AVALIAÇÃO

Cirurgia Digestiva · Estação #CD-13 · Enfermaria — Cirurgia Geral · nível difícil

Pele amarela e coceira sem dor em idoso que emagreceu

CHECKLIST — CÂNCER DE CABEÇA DE PÂNCREAS

AVALIAÇÃO CLÍNICA	Pts	Avaliação
Caracterizou a icterícia obstrutiva (progressiva, indolor, prurido, colúria, acolia) e a perda de peso Sabiston, 21ª ed.	1	☐ A ☐ P ☐ I
Pesquisou diabetes recente, tabagismo e febre (colangite) NCCN Pancreatic Adenocarcinoma, 2024	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Identificou o sinal de Courvoisier-Terrier Porto — Semiologia Médica, 8ª ed.	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

DIAGNÓSTICO	Pts	Avaliação
Formulou hipótese de neoplasia periampular / adenocarcinoma de cabeça de pâncreas NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Solicitou TC trifásica com protocolo para pâncreas e TC de tórax NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Classificou como RESSECÁVEL (contato venoso ≤ 180° sem irregularidade, artérias livres, sem metástases) NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I

CONDUTA	Pts	Avaliação
Indicou duodenopancreatectomia (Whipple) em centro de referência + quimioterapia adjuvante Conroy et al., PRODIGE 24, NEJM 2018; NCCN 2024	1,5	☐ A ☐ P ☐ I
Não indicou drenagem biliar pré-operatória de rotina (citou indicações) van der Gaag et al., NEJM 2010	0,5	☐ A ☐ P ☐ I
Citou medidas de suporte (vitamina K, nutrição, prurido) e comunicou com empatia NCCN 2024	0,5	☐ A ☐ P ☐ I

Pontuação máxima: **10,0** Nota obtida: _____ A = adequado · P = parcial · I = inadequado